



NOTA DINAS

Dari : Ns. Dhora Putri Meryda, S.Kep
Kepada : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
Perihal : Koordinasi Pelayanan Skrining Bayi Baru Lahir
Tanggal : Kamis, 23 April 2026

Isi Nota Dinas :

Dasar : 1. Perkenalan Tim Skrining Bayi Baru Lahir
2. Penyampaian materi Kebijakan Pelayanan Skrining Bayi Baru Lahir
3. Penguatan Teknis Pengambilan Sampel Skrining Bayi Baru Lahir (SHK, SHAK, dan SG6PD)
4. Evaluasi Pelaksanaan Skrining Bayi Baru Lahir Tahun 2025

Maksud & Tujuan : 1. Standarisasi Prosedur: Menyamakan persepsi mengenai tata cara pengambilan sampel (seperti tetes darah tumit) sesuai standar klinis.
2. Ketepatan Waktu: Memastikan sampel diambil pada usia emas bayi (biasanya 48–72 jam setelah lahir) dan segera dikirim ke laboratorium rujukan sebelum batas waktu stabilitas sampel habis.
3. Kelengkapan Administrasi: Menjamin data bayi terdokumentasi dengan benar untuk memudahkan pelacakan (tracing) jika hasil tes menunjukkan hasil positif atau perlu pengulangan.

Waktu : Kamis / 23 April 2026

Pelaksanaan

Nama Petugas : Ns. Dhora Putri Meryda, S.Kep

Daerah Tujuan/ : Dinkes Kab. Malang

Instansi yang : Jl. Panji No.120, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang

Dikunjungi

Hadir dalam : Koordinasi Pelayanan Skrining Bayi Baru Lahir

Pertemuan

Petunjuk / Arahan yang Diberikan (Materi) : -

FGFGPetunjuk / Arahan yang Diberikan (Materi) : 1.Kebijakan Skrining Bayi Baru Lahir

- **UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 41 ayat (3)**
upaya kesehatan bayi dan anak termasuk skrining bayi baru lahir dan skrining kesehatan lainnya,
- **PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**
- Skrining Kesehatan bertujuan mendeteksi secara dini kelainan bawaan dan masalah Kesehatan untuk dapat dilakukan intervensi dini dalam rangka mencegah kesakitan, kematian, dan kedisabilitas. Skrining Kesehatan termasuk skrining bayi baru lahir dan skrining Kesehatan lainnya.
- **Permenkes 25/2014**
Skrining Hipotiroid Kongenital merupakan bagian dari pelayanan neonatal esensial

- **Permenkes 78/2014**
Tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SHK
- **KMK 1511/2023**
Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kebidanan dan Neonatal dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- **KMK 33/2025**
Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun Skrining BBL termasuk dalam paket pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun untuk sasaran bayi

2. Skrining Bayi Baru Lahir

SKRINING BAYI BARU LAHIR



3. Waktu Pengambilan spesimen SHK, S-HAK dan S-G6PD
 - Pengambilan sampel usia bayi utk SHK, S-HAK dan S-G6PD setelah 24-72 jam pasca kelahiran
 - Bila bayi akan dipulangkan 24-48 jam pasca kelahiran.
 - Sebaiknya darah tidak diambil dalam 24 jam pertama → ada kemungkinan kadar 17-OHP dan TSH masih tinggi → positif palsu
 - Pengambilan spesimen dapat dilakukan oleh Bidan, Perawat, ATLM dan Dokter.
 - Bila bayi dipulangkan sebelum 24 jam, maka pengambilan specimen dilakukan saat kunjungan rumah atau ibu diminta membawa bayinya kembali keesokan harinya ke Fasyankes.
4. Prosedur Pengambilan Spesimen SHK, S-HAK dan S-G6PD
 - Cuci tangan dan pakailah sarung tangan.
 - Hangatkan tumit bayi yang akan ditusuk dengan cara :
 - a. Genggam dan pijat lembut bagian tumit.
 - b. Peganglah kaki bayi dengan tangan kiri dan lancet dengan tangan yang dominan (kanan pada kebanyakan orang atau kiri bila kidal) dan posisikan lebih rendah dari kepala bayi.
 - c. Genggam seluruh telapak bayi dengan tangan kiri sisakan bagian tumit yang akan ditusuk, sedikit menggenggam dengan agak keras akan mengalirkan darah ke arah tumit yang terletak lebih rendah.



TIPS

- Jangan ragu menekan lanset ke tumit → tidak akan terjadi penusukan yang terlalu dalam karena panjang lanset maks hanya 2 mm.
- Tekan tombol lanset setelah lanset menempel dengan baik ke tumit untuk memastikan tusukan cukup dalam (1-2 mm) agar darah dapat mengalir dengan baik.

- d. Setelah tumit ditusuk, usap tetes darah pertama dengan kasa steril.
 - e. Kemudian lakukan pijatan lembut sehingga terbentuk tetes darah yang cukup besar.
 - f. Hindari gerakan memeras yang dapat mengakibatkan hemolisis atau tercampur dengan cairan jaringan.
 - g. Teteskan darah ke kertas saring setelah terbentuk 1 tetesan penuh agar darah dapat mengalir bebas ke kertas saring.
- Hindari meneteskan darah 2x ke bulatan yang sama karena akan menyebabkan tetesan darah yang berlapis-lapis (layering) yang dapat menyebabkan positif palsu.
 - Bila tetesan gagal memenuhi lingkaran kertas saring, maka tetesan berikut harus diteteskan ke bulatan lainnya.
 - Bila gagal, maka ambil kertas saring baru dan coba kembali.
 - Teteskan darah ke tengah bulatan kertas saring hingga bulatan terisi penuh dan tembus di kedua sisi.
 - Ulangi meneteskan darah ke atas bulatan lain.
 - Bila darah tidak cukup, lakukan penusukan di tempat lain dengan lanset baru.
 - Agar bisa diperiksa, dibutuhkan sedikitnya tiga bulatan penuh spesimen darah pada kertas saring
 - Sesudah bulatan kertas saring terisi penuh, tekan bekas tusukan dengan kasa/kapas steril sambil mengangkat tumit bayi sampai berada di atas kepala bayi.
 - Bekas tusukan diberi plester ataupun pembalut hanya jika diperlukan.
 - Jika terjadi kesalahan spesimen, maka harus dilakukan pengambilan spesimen ulang sebelum dikirim ke laboratorium rujukan pemeriksa SHK, S-HAK dan S-G6PD
5. Pengiriman Spesimen SHK, S-HAK dan S-G6PD
- Setelah kering, maka spesimen siap dikirim ke laboratorium
 - Ketika spesimen akan dikirim, masukkan ke dalam kantong plastik zip lock. Satu lembar kertas saring dimasukkan ke dalam satu plastik. Dapat juga dengan menyusun kertas saring secara selang-seling agar bercak darah tidak saling bersinggungan, atau taruh kertas di antara bercak darah.
 - Masukkan ke dalam amplop dan sertakan daftar spesimen yang dikirim. Amplop berisi spesimen dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak tertembus cairan/kontaminan sepanjang perjalanan.



- Pengiriman dapat dilakukan oleh petugas pengumpul spesimen atau langsung dikirim melalui layanan jasa pengiriman yang tersedia.
 - Spesimen dikirimkan ke laboratorium SHK, S-HAK dan S-G6PD yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
 - Pengambilan sampel paling lambat 24-72 jam atau 3 (tiga) hari setelah lahir.
 - Transportasi untuk spesimen SHK, S-HAK dan S-G6PD paling lambat 2 hari setelah pengambilan spesimen.
6. Skrining HAK pada Kondisi Khusus
- Kondisi yang menyebabkan hasil negatif palsu:
- a. Pemberian glukokortikoid.
Pemberian dexamethason, metil prednisolon, prednison, hidrokortison pada ibu (mis. pemberian glukokortikoid untuk menginduksi pematangan paru pada kehamilan dengan persalinan prematur) maupun pemberian glukokortikoid pada bayi secara oral/parenteral.
 - b. Bayi yang sakit kritis.
 - c. Genitalia ambigu yang tidak teraba kedua gonad.
7. Skrining G6PD pada Kondisi Khusus
- Kondisi yang menyebabkan hasil normal atau tinggi palsu:
- a. Bayi prematur (umur kehamilan < 37 minggu), BBLR, bayi lahir di daerah endemis malaria, bayi lahir dari Ibu hamil yang terinfeksi malaria, dan bayi yang dirawat di NICU (sepsis).
 - b. Varian G6PD termasuk tipe Afrika.
 - c. Pasien dengan mean cell haemoglobin (MCH) sangat rendah (< 25 pg).
 - d. Seks kromosom aneuploidi jarang menyebabkan ketidakpastian interpretasi aktivitas G6PD.
 - e. Pasien laki-laki dengan sindrom Klinefelter (XXY) dan perempuan heterozigot.
 - f. Pasien dengan sindrom Turner (XO), pria dengan defisiensi hemizigot atau wanita dengan Lyonisasi ekstrem.
 - g. Sampel anemia dan leukositosis

Masalah / Temuan Di RSPHM yang relevan dengan materi	:	1. Untuk petugas yang mengambil sampel dari poli belum bisa standby karena terbatas staff 2. Untuk pengambilan sampel dari poli masih ada yang kurang memenuhi syarat
Saran / Tindakan untuk RS dari hasil pelatihan	:	1. Sosialisasi kepada tim unit terkait dalam hal pelayanan Skrining BBL 2. Memahamkan staff RS terkait pelaksanaan pengambilan sample

Tembusan :



DOKUMENTASI

